内科学含诊断学 消化系统疾病

核心精讲·肠结核 & 结核性腹膜炎

（性感认识：长期低热盗汗）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、肠结核

1.临床表现

①发热：**低热为主**，也可中热、甚至高热（伴大叶性干酪性肺炎、急性粟粒性肺结核，此时可用糖皮质激素）。约1/3 呈弛张热、少数呈稽留热

短期使用,冲击疗法

天师兄 张飞拜师结盟 鸡大姐上班

②可腹泻、可便秘、也可腹泻或便秘交替

肠结核好发于回盲部 消化系统疾病要关注部位

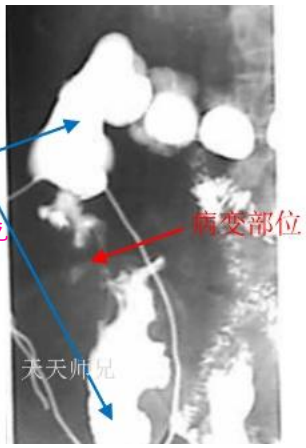
可能可能最可能：慢性低热盗汗、**右下**或脐周腹痛：

①溃疡型以腹泻为主（**多无脓血和里急后重**）毒力强,形成溃疡

②增生型以便秘和腹部肿块为主

病变在左边结肠、直肠、离肛门近,脓血多见;右边肠道出血被稀释,故脓血少见;累及直肠就会有里急后重

eg.肠伤寒好发于回肠末端,阿米巴好发于盲肠和升结肠,克罗恩好发于回肠末端和邻近结肠



2.多**经口**感染，主要来自**空洞性肺结核**

反复咽下含结核杆菌的痰液

3.**肠梗阻是肠结核、结核性腹膜炎、克罗恩病最常见的并发症**（罗姐姐）

环形溃疡,横形溃疡→瘢痕收缩

4.检查

结核

①**结肠镜（首选和金标准）**：好发于**回盲部**的**环/横形溃疡**或肿块，**干酪肉芽肿**、抗酸杆菌（还回盲盒）

②**钡灌肠**：溃疡型呈**跳跃/激惹征**（病变的上、下肠段钡剂充盈良好）钡剂刺激溃疡部位的裸露神经,肠道迅速收缩排空钡剂

③抗结核 2-6 周试验性治疗

注意：大便、痰液找到结核杆菌**不**能确诊肠结核

咽下含TB的痰液≠得肠结核

5.治疗

（1）关键：抗结核治疗，多用短程疗法 抗结核治疗不良反应大

（2）手术：①诊断困难需开腹探查者；②急性肠穿孔；③完全性肠梗阻；④慢性肠穿孔瘘管形成、不完全性肠梗阻、或肠道大出血经内科治疗无效者 易导致继发性腹膜炎

二、结核性腹膜炎

可能可能最可能：慢性低热盗汗、ttsx 多**揉面/柔韧感**。弥漫性腹膜炎，多为脐周、下腹或全腹的隐痛

《诊断学》：揉面感见于结核性腹膜炎、癌性腹膜炎、血性腹水（血液对腹膜刺激最轻微）等

VS 消化性溃疡穿孔→消化液流入腹腔→消化液对腹膜的刺激最强→刀割样剧痛、典型腹膜刺激征（压痛、反跳痛、腹肌紧张）

1.多腹腔内结核灶（肠结核、肠系膜淋巴结结核、输卵管结核）直接蔓延

女性生殖系统结核:以输卵管结核最常见

2.检查

（1）腹腔镜：金标准（广泛腹膜粘连禁用）